
SEMIOLOGIE DES SPLENOMEGALIES

Dr Atoumane FAYE

09/01/2017

OBJECTIFS

- Définir la splénomégalie
- Décrire les caractères d'une splénomégalie à l'examen physique
- Décrire la classification de Hackett
- Citer 4 étiologies de splénomégalie d'origine bactérienne, 3 d'origine parasitaire et 3 d'origine virale
- Citer 4 étiologies de splénomégalie d'origine hématologique et 3 étiologies d'origine inflammatoire

PLAN

I - INTRODUCTION

I- 1. Définition

I- 2. Intérêt

II - SEMIOLOGIE ANALYTIQUE

II- 1. Circonstances de découverte

II- 2. Examen physique

II- 3. Classification des splénomégalies

II- 4. Examens paracliniques

III - DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

IV - ETIOLOGIES

CONCLUSION

INTRODUCTION

I- 1. Définition

Splénomégalie =

- ❑ Augmentation du volume de la rate qui devient palpable à l'examen clinique ou
 - ❑ Rate mesurant plus de 14 cm de grand axe à l'échographie ou au scanner
-

INTRODUCTION (2)

I- 2. Intérêt

- ❑ Diagnostic essentiellement clinique
 - ❑ Toute rate palpable est pathologique
 - ❑ Etiologies multiples dominées par les pathologies infectieuses et les hémopathies malignes.
 - ❑ Nécessité d'une démarche diagnostique
-

ANALYSE SEMIOLOGIE

II- 1. Circonstances de découverte

- douleur ou pesanteur hypochondre gauche, irradiant vers épaule homolatérale, exagérée par l'inspiration profonde ou
 - masse hypochondre gauche (notée par patient ++)
-

ANALYSE SEMIOLOGIQUE

- Au décours de complications (très rare):
rupture de rate, infarctus splénique
- découverte fortuite à l'échographie ou au scanner ou lors anomalies hémogramme (thrombopénie, leucopénie, pancytopénie)

ANALYSE SEMIOLOGIQUE

1- Interrogatoire

- Terrain: âge, race, profession, éthylisme, comportement sexuel à risque,
- Antécédents personnels et familiaux
- Début (aigu/ chronique) et mode évolutif
- Signes associés (SF et SG): douleur hypochondre gauche (signant infarctus ou rupture splénique), pâleur des muqueuses, fièvre, AEG,

ANALYSE SEMIOLOGIQUE

2- Examen physique

- Inspection: voussure hypochondre gauche
- Palpation: sujet en décubitus latéral droit ou dorsal en fin d'inspiration => masse hypochondre gauche dirigée en bas et en dedans, bord antéro-interne crénelé, mobile avec la respiration sans contact lombaire.

ANALYSE SEMIOLOGIQUE

2- Examen physique (2)

Le débord splénique doit être mesurée à l'aide d'un calque +++ ce qui permettra de suivre l'évolution de la splénomégalie.

ANALYSE SEMIOLOGIQUE

2- Examen physique (3)

Examen physique recherchera:

- adénopathies
- hépatomégalie ou atrophie hépatique
- signes d'hypertension portale
- ictère

Examen physique doit être complet ++++

ANALYSE SEMIOLOGIQUE

3- Classification des splénomégalies = classification de HACKETT

- ✓ type 1: rate à peine palpable sous le gril costal.
- ✓ type 2: rate dépasse le rebord costal mais n'atteint pas la ligne horizontale passant par l'ombilic.
- ✓ type 3: rate atteint ligne horizontale passant par l'ombilic.

SEMIOLOGIE ANALYTIQUE

3- Classification de HACKETT (2)

- ✓ type 4: rate dépasse la ligne ombilicale et atteint la ligne passant par les épineuses
- ✓ type 5 : rate plonge dans la fosse iliaque

ANALYSE SEMIOLOGIQUE

4- Examens paracliniques

- ☐ Echographie abdominale + + + : rate avec grand axe supérieur à 14 cm
- ☐ Scanner abdominal
- ☐ Autres examens dans le cadre d'une orientation étiologique : NFS, réticulocytes, frottis sanguin, transaminases, bilirubine, haptoglobine , radiographie thorax

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Gros rein gauche: contact lombaire ,
ballottement rénal
- Tumeur angle colique gauche: troubles du transit ,
masse hypochondre gauche
- Tumeur méésentérique: troubles du transit ,
masse mobile par rapport aux 2 plans,
- Tumeur queue pancréas
- Tumeur gastrique
- Tumeur lobe gauche foie

ETIOLOGIES

1- Causes infectieuses

1- 1. Infections bactériennes

Contexte infectieux, splénomégalie aiguë souvent type 1 ou 2

- Sepsis à germes banals
- Endocardite infectieuse ou maladie d'Osler (notion de valvulopathie, modification souffle cardiaque, hémocultures, échographie cardiaque)

ETIOLOGIES

1- Causes infectieuses

1- 1. Infections bactériennes (2)

- Tuberculose organes hématopoïétiques
Notion de contagé, fièvre prolongée vespéro-nocturne, IDR t positive, pancytopénie
- Fièvre typhoïde: dissociation pouls-température, hémocultures, sérodiagnostic de Widal
- Brucellose: contact animaux, fièvre ondulante, sudoro-algique, hémocultures , sérodiagnostic de Wright

ETIOLOGIES

1- Causes infectieuses

1- 2. Infections virales

- Mononucléose infectieuse
 - Hépatites virales
 - Infection à VIH : notion de comportement sexuel à risque , usage drogue IV, ...
-

ETIOLOGIES

1- Causes infectieuses

1- 3. Infections parasitaires

- Paludisme: TDR/GE, parfois évolution chronique (paludisme viscéral évolutif)
- Bilharziose : notion baignade en eau douce, diarrhée dysentérique, hépato-splénomégalie, hyper-éosinophilie, biopsies muqueuse rectale
- Autres: leishmaniose viscérale, toxoplasmose

ETIOLOGIES

2- Causes inflammatoires

Terrain: souvent femme jeune , fièvre prolongée, polyarthralgies ou polyarthrite, lésions cutanées (érythème, vitiligo, alopecie), œdème type rénal avec protéinurie ,

- Lupus érythémateux systémique
- Syndrome de Felty (PR, SPM, neutropénie)
- Maladie de Still
- Sarcôïdose

ETIOLOGIES

2- Causes hématologiques

2- 1. Anémies hémolytiques

Clinique: pâleur, ictère hémolytique chronique,

Biologie: élévation bilirubine indirecte et LDH
chute haptoglobine

- Anémies hémolytiques auto-immunes
- Hémoglobinopathies (drépanocytose, thalassémies)
- Syndrome de Minkowski-Chauffard
- Déficit en G6PD ou en pyruvate kinase

ETIOLOGIES

2- Causes hématologiques

2- 2. Hémopathies malignes

- Leucémies aiguës: tableau de polyADP aigu fébrile + SPM avec blastose sanguine et médullaire
- Lymphomes malins (maladie de Hodgkin et LMNH)
- Syndromes myéloprolifératifs (LMC, splénomégalie myéloïde chronique, maladie de Vaquez,)

ETIOLOGIES

3- Causes vasculaires

Syndrome d'hypertension portale avec CVC abdominale, ascite, splénomégalie

- Causes supra-hépatiques : syndrome de Budd-Chiari, insuffisance ventriculaire droite
- Causes intra-hépatiques: cirrhose ++++
- Causes infra-hépatiques: thrombose portale ou splénique

ETIOLOGIES

4- maladies de surcharge

- Amylose
 - Hémochromatoses
 - Maladie de Niemann-Pick
 - Maladie de Gaucher
-

ETIOLOGIES

5- Splénomégalies tumorales

- Kyste
- Tumeurs malignes (exceptionnelles):
primitives (lymphome, sarcome, ...) ou
secondaires

CONCLUSION

- ❑ Diagnostic splénomégalie aisé
 - ❑ Diagnostic étiologique : multiplicité des étiologies
 - ❑ Démarche diagnostic rigoureuse
-